¿Persiste el impacto de vivir un terremoto con 0 a 4 años?



Shock	27-F de 2010, magnitud 8,8
Expuestos	Niños de 0 a 4 años

Efectos de shocks en la primera infancia

Peso al nacer (Torche, 2011)

Desarrollo cognitivo y no cognitivo (Gillmore, 2026)

Talla y aprendizaje (Andrabi, Daniels y Das, 2023)

Salud mental adulta (Persson y Rossin-Slater, 2018)

Este trabajo

Salud mental en la adolescencia, a los 15–18 años

¿Importa la edad en la que se vive el shock?

"The effects of stress on the brain depend critically on the timing (age of onset and duration). When stress occurs early in life it can have profound and lasting effects on brain organization and function."

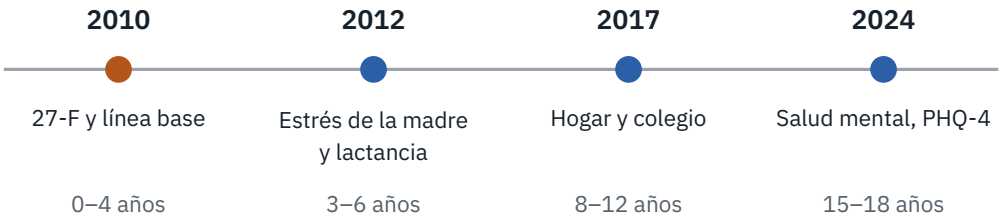
(Gee y Casey, 2015, p. 184)

Mecanismos posibles

	Cómo opera
Entorno socioeconómico y familiar	El terremoto reduce ingresos, daña la vivienda y aumenta el conflicto entre los padres
Transmisión del estrés de la madre	El lactante regula su estrés a través de la madre. Si ella está estresada, se lo transmite en el contacto diario

Entorno, Conger y Donnellan 2007; Almond, Currie y Duque 2018. Transmisión del estrés, Persson y Rossin-Slater 2018 en el embarazo; Waters, West y Mendes 2014 y Hostinar, Sullivan y Gunnar 2014 después del parto.

Qué datos utilizamos



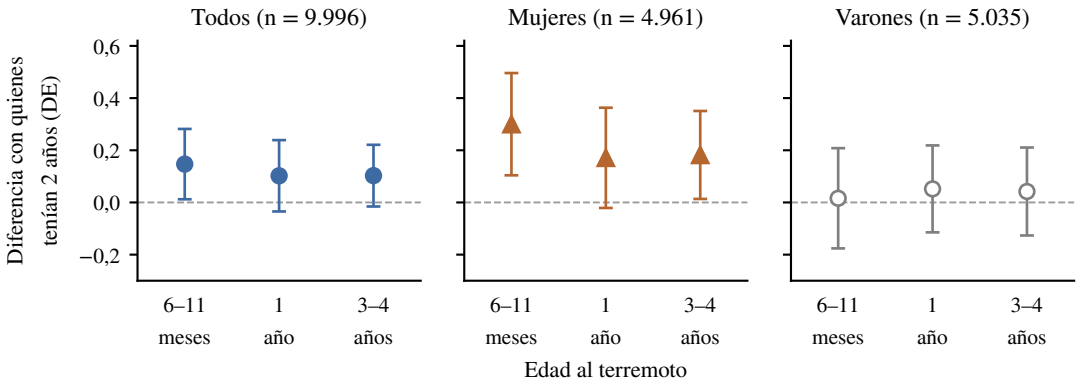
Encuesta	ELPI, Encuesta Longitudinal de Primera Infancia
Muestra	9.996 adolescentes nacidos en 2006–2009, 4.961 mujeres
Responde	La madre o el cuidador hasta 2017; el adolescente en 2024

Especificación econométrica

$$Y_{imc} = \sum_{a \neq 2} \beta_a \left(\text{Edad}_{ai} \times \text{Afectada}_m \right) + \sum_{a \neq 2} \gamma_a \, \text{Edad}_{ai} + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc}$$

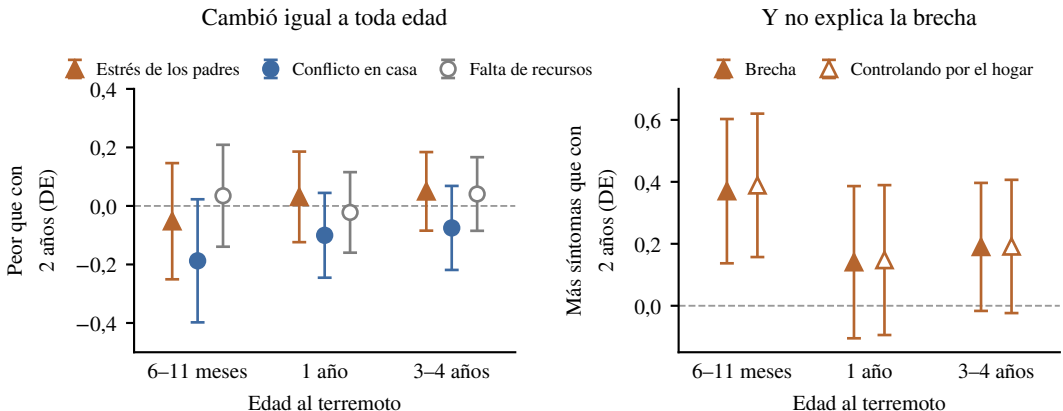
Y_{imc}	Salud mental a los 15–18 años, PHQ-4
Edad_{ai}	Edad al terremoto: 6–11 meses, 1 año o 3–4 años; referencia, 2 años
Afectada_m	Comuna en la zona de daño destructivo
ψ_m, θ_c	Efectos fijos de comuna y de cohorte de nacimiento
X_i	Controles del niño y del hogar

Efecto sobre la salud mental



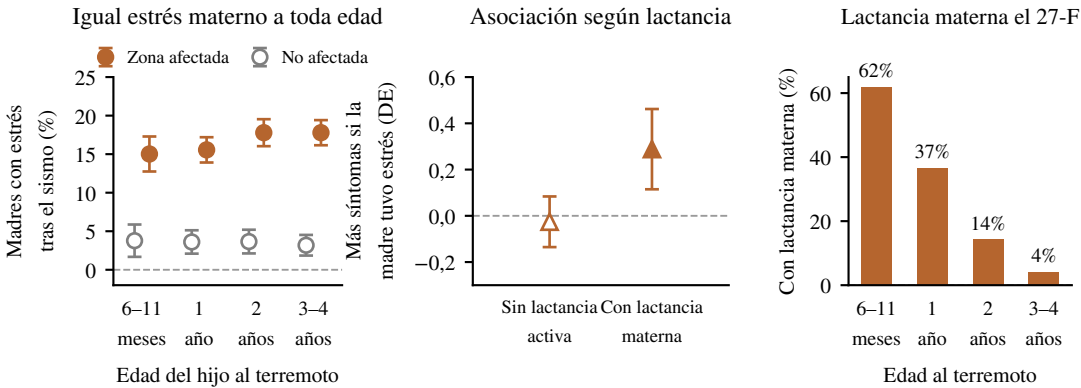
La salud mental se mide con el PHQ-4, consistente en cuatro preguntas que responde el adolescente sobre síntomas de ansiedad y depresión (nervios, preocupación, pérdida de interés y decaimiento); Kroenke et al. 2009. Cada punto es la diferencia entre comunas afectadas y no afectadas, con IC al 95 %.

El entorno socioeconómico y familiar no explica la brecha



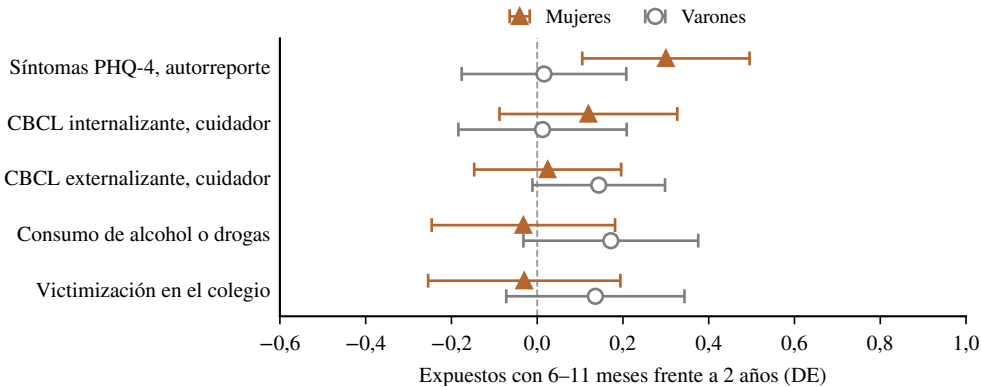
Índices de 2012 y 2017 que reporta la madre o el cuidador. Mujeres, frente a quienes tenían 2 años; IC al 95 %, a la derecha por bootstrap de comunas.

Estrés materno y salud mental de las hijas según la lactancia



La lactancia materna activa el 27-F actúa como proxy de dependencia regulatoria y proximidad bioquímica/conductual con la madre. Mujeres, con EF y controles, también por educación y empleo de la madre y por edad; IC al 95 %.

En varones, solo indicios débiles en conducta y consumo



Es habitual que los padres no detecten la ansiedad y la depresión de sus hijos adolescentes; en la muestra, PHQ-4 y CBCL correlacionan 0,30; Achenbach et al. 1987; De Los Reyes et al. 2015. En varones, ambas asociaciones son significativas solo al 10 %.

Lo que sugieren los datos y lo que queda abierto

Lo que sugieren los datos

- Las expuestas entre los 6 y los 11 meses tienen peor salud mental que las expuestas a los dos años, 0,30 DE en el PHQ-4.
- El entorno socioeconómico y familiar cambió de forma similar en todas las edades y no explica esa diferencia.
- El estrés materno solo se asocia a peor salud mental en las hijas con lactancia materna, el 62 % de las expuestas entre los 6 y los 11 meses.

Lo que queda abierto

- La medida de estrés materno es binaria y retrospectiva, por lo que su contribución probablemente está subestimada.
- Qué explica el efecto a los 3–4 años, que no opera a través del entorno familiar ni del estrés materno.

En varones no hay efecto sobre la salud mental; solo indicios débiles en conducta y consumo.